

Standardy nieosiągalne — *mechanizm dodatkowy CBT-E*

Perfekcjonizm kliniczny: sztywne, wysokie standardy, samoocena oparta na ich osiągnięciu, kontynuacja mimo kosztów. W AN — paliwo dla kontroli wagi.

CZAS: 1–2 sesje psychoedukacji + moduł CBT-E enhanced

REALIZACJA: CBT-E enhanced, jeśli perfekcjonizm jest centralnym mechanizmem

ŹRÓDŁO: Shafran, Cooper & Fairburn (2002, *Behav Res Ther*); Fairburn (2008, rozdz. 13, moduł perfekcjonizm); Egan i in. (2014, CBT for perfectionism)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **trzy cechy perfekcjonizmu klinicznego** wg Shafran (2002) + jak różni się od „zdrówego dążenia do sukcesu”. Sekcja 02 — **siedem kroków pracy** (moduł CBT-E enhanced). Sekcja 03 — **arkusz „moje standardy”**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Perfekcjonizm kliniczny (Shafran, Cooper & Fairburn, 2002) — *nie* jest tym samym co „zdrówego dążenie do sukcesu”. Trzy cechy: (1) *sztywne, wysokie* standardy w kluczowych obszarach życia; (2) samoocena *nieproporcjonalnie* oparta na ich osiągnięciu; (3) *kontynuacja* mimo widocznych kosztów (zdrowie, relacje, jakość życia). W AN perfekcjonizm jest jednym z trzech głównych *dodatkowych* mechanizmów podtrzymujących (obok niskiej samooceny i niskiej tolerancji afektu) — wymaga osobnego modułu CBT-E enhanced (Fairburn, 2008, rozdz. 13). **Mechanizm w AN:** standardy są nieosiągalne → frustracja → kontrola wagi staje się jedyną domeną „w której można odnieść sukces” → wzmacnia AN. Bez pracy nad perfekcjonizmem — pacjent po remisji AN przenosi go w inny obszar (praca, sport).

01 📋 Trzy cechy perfekcjonizmu klinicznego (Shafran, 2002)

CECHA

CO KONKRETNIE SIĘ DZIEJE

1 · Sztywne wysokie standardy	Standardy „najlepszego/-a”, „bez błędów”, „doskonałe” w obszarach kluczowych (nauka, praca, kontrola wagi). Sztywne — nie do negocjacji, nawet w trudnych warunkach (choroba, kryzys).
2 · Samoocena oparta na standardach	„Jestem wartościowy/-a wtedy, gdy osiągam standardy”. Najmniejsza porażka = totalna porażka. Czarno-biały podział. Sukces nie jest świętowany — jest <i>jednorazowy minimum</i> , zaraz nowy cel.
3 · Kontynuacja mimo kosztów	Zdrowie, relacje, sen, jakość życia — wszystko jest poświęcane standardom. Mimo widocznych kosztów standardy nie spadają — pacjent „ <i>musi jeszcze bardziej się starać</i> ”. To samonapędzająca pętla.

Perfekcjonizm kliniczny ≠ zdrowe dążenie do sukcesu. Zdrowe: standardy są kontekstowe (różne w różnych obszarach), samoocena ma wiele filarów, koszty są brane pod uwagę. Kliniczny: sztywne, monofilarowe, ignorujące koszty. To jakościowa różnica.

02 Siedem kroków modułu CBT-E enhanced

1. **Psychoedukacja** — „Perfekcjonizm wydaje się być Twoją siłą — i był nią. Ale w AN stał się mechanizmem podtrzymującym. Standardy są nieosiągalne — kontrola wagi staje się jedyną domeną „udaną”. Bez pracy nad tym, AN będzie wracać”.
2. **Identyfikacja obszarów** — w jakich dziedzinach pacjent stosuje perfekcjonizm: nauka/praca, kontrola wagi, sport, sprzątanie, wygląd, relacje. Lista konkretnych standardów w każdej.
3. **Zarysowanie kosztów** — dla każdego standardu: „co Cię to kosztuje? Zdrowie, sen, relacje, radość, jakość życia?”. Bez wyliczenia kosztów — pacjent nie widzi sensu zmiany.
4. **Eksperymenty z obniżeniem standardów** — wybierz jeden obszar (najlepiej peryferyjny — nie kontrolę wagi). Pacjent celowo działa poniżej swoich standardów: oddaje pracę „dobrą”, nie „idealną”; ćwiczy 30 min, nie 60 min; akceptuje, że pokój jest „w porządku”, nie „nieskazitelny”.
5. **Tolerancja niepokoju** — po eksperymentach pacjent czuje niepokój: „to nie wystarczy”, „jestem leniwy/-a”. To normalne. Lęk osiąga szczyt w 30–60 min, potem spada. Pacjent uczy się: można żyć ze standardem „wystarczająco dobrze”.
6. **Rozszerzenie samooceny** — równolegle pacjent rozwija inne domeny samooceny (zob. karta nadwart i pie-chart). Standardy w jednej domenie tracą na wadze, kiedy są inne źródła wartości.
7. **Praca z czarno-białym myśleniem** — perfekcjonizm operuje binarnie: „sukces / porażka”. Wprowadzenie skali („jak na 1–10 oceniam to?”) rozbija binarność. Większość rzeczy w życiu to 6–8, nie 10 albo 0.

03 Moje standardy — arkusz

OBSZAR	MÓJ STANDARD (KONKRETNIE)	CO MNIE TO KOSZTUJE	EKSPERYMENT
--------	---------------------------	---------------------	-------------

Klucz: perfekcjonizm kliniczny to *siostra* AN — często z nią rośnie i z nią pracuje. Jeśli zostawimy perfekcjonizm nietknięty, pacjent po remisji AN przeniesie go w inny obszar — praca, sport, rodzicielstwo, ascetyzm. **Komunikat dla pacjenta:** „nie chcę odebrać Ci Twojej dyscypliny i ambicji — to są realne zasoby. Chcę pomóc Ci je „odsztynować”: żebyś mógł/mogła być ambitny/-a w tym, na czym Ci zależy, i jednocześnie sobie wybaczać nieperfekcję. Standard „wystarczająco dobrze” nie jest „leniwe” — jest realny i zdrowy”.

⚠ **Perfekcjonizm dziedziczony:** u wielu pacjentów perfekcjonizm jest „rodzinny” — wyniesiony z domu (perfekcjonistyczni rodzice, kultura osiągnięć). Praca z perfekcjonizmem często ujawnia konflikt z rodziną („moi rodzice nie zaakceptują „wystarczająco dobrze”). To może wymagać włączenia rodziny lub pracy nad granicami z systemem rodzinnym.